

06 - 1 généralités rhumato sono maker

Je suis professeure de cours, je suis professeure en Rhumatologie. Je vais traiter avec vous, nous avons encore 6 heures, d'accord ? Nous allons traiter la sébiologie en Rhumatologie, d'accord ? Alors la sébiologie, j'aimerais bien vous prévenir, c'est la bête noire de ce semestre, d'accord ? C'est pourquoi, ça commence bien, c'est pourquoi. Alors, on va commencer sur de bonnes bases et de bonnes règles.

Vous avez 8 spécialités, et chaque spécialité, c'est des nouveaux termes, d'accord ? Et vous devez tout apprendre, sinon pour l'examen, c'est pour toute votre vie, c'est pour préparer l'interrogatoire, l'examen. C'est pour ça, je demande toute votre attention. De ma part, je vais essayer de vous aider à apprendre, d'accord ? On va aller très doucement, je sais que c'est des nouveaux termes pour vous, et on va prendre notre temps, c'est bon ? Alors aujourd'hui, nous allons voir les généralités, d'accord ? Et nous allons voir deux petites vidéos pour vous, c'est-à-dire, vous initier à l'interrogatoire, d'accord ? Demain, incha'Allah, nous allons voir l'examen de l'épaule, l'examen du rachis.

Et vendredi, l'examen du genou, l'examen de la hanche. Et à la dernière heure, nous allons voir ensemble quelques questions et quelques QCM, d'accord ? Pour la dernière séance, j'aimerais bien que vous profitiez et que vous révisiez comme ça. Vous allez dire, c'est bon pour la sébiologie de l'art de maternité.

Très bien ! Alors, c'est quoi l'art de maternité ? Quelqu'un sait ? Ça traite quoi ? Pardon ? Les articulations, très bien. Alors, pour l'appareil de commandeur, comme pour tous les appareils, il y a deux spécialités. Vous allez trouver la spécialité médicale qui traite toutes les pathologies, toutes les maladies qui peuvent affecter cet appareil.

D'accord ? Et vous allez trouver, de l'autre côté, la spécialité chirurgicale. C'est elle qui va s'occuper de toutes les chirurgies. D'accord ? La rhumatologie s'occupe de toutes les maladies qui intéressent l'appareil de commandeur chirurgical.

Alors, on exclut de ça les traumatismes, on exclut de ça les fractures. Vous allez voir ça avec une image en rouge. Qu'est-ce qui amène le patient à consulter ? La douleur.

Est-ce que quelqu'un a déjà eu une douleur particulière de l'appareil de commandeur ? Les garçons ? Vous n'avez pas eu de douleur ? De quelle douleur, mademoiselle ? Pardon ? En direct de ? De l'école. Très bien. Alors, quand vous allez recevoir votre patient, c'est quoi la première étape ? L'identité.

Très bien. Quoi d'autre ? Le type de consultation. Les antécédents.

Ça sert à quoi les antécédents ? Très bien. C'est quoi les antécédents ? On va se savoir avec. Ça veut dire tout ce que le patient a eu avant son arrivée chez lui.

D'accord ? Ça peut avoir une relation avec sa pharmacologie. Vous allez chercher le diabète de façon systématique. Pourquoi ? Pardon ? Le risque de nécrose.

L'amputation. Très bien, voilà. Là, c'est chirurgie.

C'est la traumatie. Oui. Le diabète.

C'est toujours important à préciser. Pourquoi ? Ça va vous servir pour le traitement, par exemple. D'accord ? Si maintenant vous pensez à donner la corticothérapie, attention.

Les diabétiques, les corticoïdes vont augmenter la glycémie. Par exemple, vous voyez que chaque petit symptôme, chaque antécédent peut avoir une grande importance. D'accord ? Maintenant, nous avons connu le patient.

Nous avons vu ses antécédents. On va s'intéresser à notre motif de consultation. Qu'est-ce qui est important à sortir de la convocation chez le patient ? La douleur.

Je vous dis, j'ai mal là. Bien. Qu'est-ce que vous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Par exemple ? Histoire de l'analogie.

Très bien. Quand ça a commencé ? Quand ? Ça veut dire ? Est-ce que c'est une douleur qui est apparue, qui est récente, qui est apparue hier, avant-hier, aujourd'hui ? Est-ce que c'est une douleur que je traîne depuis longtemps ? Très bien. Quoi d'autre ? Très bien.

Est-ce qu'il y a un élément qui a déclenché ma douleur ? Par exemple ? Est-ce que j'ai eu une chute négligée depuis deux mois ? J'ai eu une chute et maintenant je commence à avoir mal. D'accord. Quoi d'autre ? Oui.

Très bien. Ça veut dire ? La localisation. Vous allez me demander est-ce qu'il y a un point particulier douloureux.

D'accord ? Ou bien c'est toute l'articulation. Est-ce que cette douleur prend naissance au niveau du racisme ? C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'il faut préciser.

Est-ce que je vous dis j'ai mal là ? Est-ce que c'est effectivement mon épaule qui est source de la douleur ? Est-ce que ça vient d'ailleurs ? Ça peut venir du racisme. La douleur au niveau de l'épaule gauche, ça peut venir du cœur. Je peux avoir plutôt la visicule binaire qui irradie, qui va me donner une douleur au niveau de l'épaule, etc.

D'accord ? Ça sert à ça l'interrogatoire. Finalement, un interrogatoire sert à avoir une orientation. Vous ne pouvez pas, parce que le patient, à la fin, va vous demander « Qu'est-ce que j'ai ? » Vous n'allez pas lui dire « Ah, on va vous demander une échographie, on va vous demander une radiographie, une échographie pour voir qu'est-ce que vous avez.

» Non. Vous devez lui donner une première explication. Comment c'est possible ? Par une chose très importante.

C'est par l'anatomie. On ne peut pas réussir un examen clinique, on ne peut pas avoir une bonne orientation si nous ne connaissons pas l'anatomie. Si je vous dis que j'ai mal là, avec les deux doigts, vous devez connaître ce point correspond à quoi, ce point correspond à quoi.

Si je ne sais pas qu'au niveau de la tête du perronné se termine le biceps, je ne pourrai jamais dire au patient « Je suspecte qu'il y a une tumeur clinique de biceps. » C'est bon ? Très bien. Tout d'abord, l'acte oratoire, c'est un peu policier.

D'accord ? On préfère le mot anamnèse. Pourquoi ? Parce que vous imaginez un patient, un patient qui va peut-être vous parler de des choses intimes. Vous allez, vous devez lui poser des questions « Est-ce qu'il prend des drogues ? Est-ce qu'il a des rapports sexuels non protégés ? » S'il ne vous fait pas confiance, c'est sûr qu'il va vous dire « Non, non, non.

» D'accord ? C'est pourquoi on préfère anamnèse. Ça veut dire que je dois mettre un patient tout d'abord en confiance, en confort. D'accord ? Et il doit tout me dire et ne pas avoir honte parce que moi, je ne le juge pas.

On ne doit pas juger les patients. On est là pour les aider. Si je pose une question sur les rapports sexuels à risque, c'est parce que j'ai en tête, je pense, un problème infectieux lié à l'urébrite.

Par exemple. Je ne rentre pas dans sa vie personnelle. C'est bon ? Très bien.

Alors, nous aurons l'objectif aujourd'hui de revenir un peu sur l'anatomie de l'articulation normale. Reconnaître l'origine d'une douleur endomatologique parce qu'en fait, la douleur peut être osseuse, c'est l'os, comme ça peut être l'articulation, le muscle, ou neurologique, c'est le nerf et non pas l'articulation. D'accord ? Savoir définir les caractéristiques psychologiques de la douleur.

Une douleur peut être mécanique, elle peut être, intérieurement voire, aiguë, chronique. Connaître les échelles d'évaluation d'une douleur. Savoir définir c'est quoi ? Arthralgie, Arthrite, Mono, Oligo, Polyarthrite.

Savoir examiner une articulation. D'accord ? Par les différents temps de l'examen. Savoir reconnaître les amplitudes articulaires.

Reconnaître le synovite, Arthrite, et penchement. Et finalement, quelques particularités de deux grandes pathologies, notamment l'arthrose, vous devez certainement déjà entendre ce mot, et l'arthrite. La rhumatologie prend son nom de rheumatismos, qui a une origine grecque, qui veut dire rupture.

La rhumatologie étudie les affections. Affection, c'est maladie ou également pathologie.

D'accord ? Les trois, de l'appareil locomoteur, qui comprennent les articulations, les os, les muscles et tendons.

Alors schématiquement, il peut s'agir, soit comme notre camarade a dit, c'est un seul élément d'une articulation qui est atteint. J'ai une tendinite, on dit l'empathie, de la force des motoneurones d'innervation. Ça veut dire que c'est un seul élément qui est lésé.

Comme ça peut rentrer dans un rhumatisme inflammatoire chronique. Qui dit rhumatisme inflammatoire chronique ? Le patient vient avec une symptomatologie articulaire. Il a des gonflements, avec des douleurs, de toutes les articulations.

Mais ce qui est à l'intérieur, on va le chercher. Pourquoi ? Parce que ces rhumatismes sont des maladies de système. Ça veut dire que, ce rhumatisme, à part l'atteinte articulaire, il peut atteindre le foie, le rein, le poumon, l'œil.

C'est pourquoi on parle de maladies de système. Les maladies rhumatismales, elles représentent un vrai problème de santé publique. Pourquoi ? Elles constituent le premier motif de consultation.

Elles sont source d'handicap. Vous allez voir, parce que c'est des millions de journées de travail perdues, des mises en invalidité, et l'aggravation, bien sûr, avec le vieillissement de la peau. Alors, le corps humain, quand il est si haut, relié par plus de 100 articulations, les articulations sont conçues pour permettre la grande mobilité, l'amplitude de mouvement, et l'appareil de commande assure la posture, la mobilité, ainsi que la marche.

L'articulation, vous reconnaissez ? Ça, c'est ? Le genou. Oui. Alors, ça, vous le savez.

Le cartilage. Le cartilage, qui est un tissu conjonctif lisse, non-vascularisé, qui veut dire non-vascularisé, non-innervé. Quand il est là, c'est pourquoi vous avez pas de mal, vous n'avez pas de peur.

Vous faites le sport que vous voulez. Vous avez toutes les articulations qui sont encore recouvertes de cartilage. Dès qu'il va y avoir la dégénérescence du cartilage, c'est la douleur, c'est le début de l'arthrose.

C'est très important le cartilage. Il recouvre les extrémités osseuses de toutes les articulations mobiles. La membrane synoviale, celle en rose, c'est cette membrane qui remplit, qui tapisse la face interne de la capsule des articulations.

Elle est très importante. Pourquoi ? Et le secret ? Le liquide synovial. D'accord ? C'est par ce liquide synovial que l'articulation se nourrit.

Alors, il est présent à l'état normal, à renouvellement interne du liquide, en petites quantités. Dès qu'il y a un problème, qu'il soit mécanique, qu'il soit interne, il va y avoir une augmentation de ce

liquide par réaction de cette membrane synoviale. D'accord ? La capsule articulaire.

La capsule articulaire, c'est un moyen de protection. Très bien. Parce que c'est elle qui vient.

Elle est élastique. C'est elle qui ferme et qui protège notre articulation. C'est elle qui assure la stabilité de l'articulation.

On voit ici les ligaments. Alors là, un exemple de ligament papillaire. Les ligaments, c'est un tissu fibreux conjonctif très résistant et élastique.

Et ils unissent là aussi les os entre eux. Les tendons. Les tendons, c'est l'interminaison du muscle.

D'accord ? C'est une bandelette du tissu fibreux qui relie les muscles aux os qui doivent mouvoir. Et on trouve cette bourse serreuse qui sent des petites poches remplies de liquide synovial. D'accord ? Elle est très visqueuse.

Et là aussi, c'est coloré et empêche le contact direct entre le tendon avec l'os qui est rugueux. C'est un moyen de protection. Ce sont deux feuilles qui sont collabées.

À l'intérieur, il y a un petit liquide qui est visqueux. Ils peuvent se remplir quand on a une inflammation. Et on parle de bourse.

D'accord ? Alors, la douleur. Comment je peux reconnaître toujours de la douleur de l'épaule ? Comment je peux faire la part ? Est-ce que c'est une douleur osseuse ? Est-ce que c'est une douleur articulaire ? Le toucher. Le toucher.

Très bien. La palpation. C'est le toucher.

Je palpe quoi ? Je cherche quoi ? Le muscle de l'os. Le muscle de l'os. L'articulation.

On voit peut-être que il y a eu la douleur. C'était comment ? C'était très intense ? Quand vous avez la douleur très intense, est-ce que vous allez laisser même le patient vous... C'est très douloureux. D'accord ? Mais c'est pourquoi une mobilisation très douce, s'il s'agit maintenant d'une douleur osseuse, l'articulation va être quand ? Va être libre.

Je vais prendre le bras et je vais m'amuser à faire une petite mobilisation. Le patient va plus mal. Je suis sûre que ce n'est pas mon articulation et c'est au palpé que je vais voir la douleur.

C'est très important. Qu'est-ce que c'est une douleur osseuse ? Est-ce une douleur articulaire, musculaire ou tendineuse ? On va voir ça d'étape. La douleur osseuse, il peut être de siège épiphysère, métaphysère ou diaphysère.

S'il vous plaît, pour les gens qui sourient, qui parlent entre eux, vous n'avez pas besoin de devant moi. Mais je vous dérange. Je n'ai pas de problème.

Ceux qui veulent sortir, la porte est ouverte. Je préfère travailler. Ceux qui veulent réussir, je ne veux pas être dérangé.

C'est la dernière fois que je fais des traumatismes. La douleur osseuse peut être de siège épiphysaire, métaphysaire ou diaphysaire. L'articulation n'est pas douloureuse à la mobilisation facile et douce.

Et à l'attraction, on va voir la douleur à l'appui sur l'os. Parfois, vous allez voir, il y a une tuméfaction, une déformation, une fracture associée. Par exemple, la tumeur osseuse ou l'ostéogénite.

Voici quelques exemples de pathologies osseuses. Vous voyez que l'articulation est normale. Mais vous imaginez que la douleur est plus importante que le patient ressent la douleur au niveau de toute la main.

D'accord ? La douleur articulaire c'est une douleur en regard de l'articulation. L'articulation est douloureuse à la mobilisation passive et active. C'est quoi passive et active ? Passive et active, c'est par rapport au patient.

J'ai mal à l'épaule. De façon active, c'est par rapport au patient. Je vais lui demander de faire quelques mouvements.

Moi, je ne fais rien. Active. Passive, c'est moi qui fais les mouvements.

C'est le médecin qui fait la mobilisation. D'accord ? On va trouver, bien sûr, quand j'ai mal à l'articulation, je vais avoir mal à faire tous les mouvements. C'est ce qu'on appelle la raideur ou bien la limitation de la mobilité.

D'accord ? Exemple, vous voyez le patient qui a un genou qui est augmenté, qui est gonflé. Et, qu'est-ce que vous remarquez là ? C'est qu'il n'arrive plus à mettre le membre bien étendu. C'est ce qu'on appelle le flex.

C'est dû à cette douleur, à cette augmentation de taille. La douleur musculaire, d'accord ? Regardez, voici l'articulation. Il n'est pas tuméfié, il n'est pas douloureux à la mobilisation et vous voyez, il y a bien une tuméfaction au niveau des parties molles.

Au contraire, à l'opposé, vous remarquez qu'il y a une diminution des masses musculaires, ce qu'on appelle la myotrophie. D'accord ? La douleur neurologique. Alors maintenant, pour notre patient, il y a une douleur au niveau de l'épaule.

Je lui ai demandé de faire la mobilisation active et normale. La mobilisation passive, normale. Qu'est-ce qu'on va déduire ? Que le problème ne vient pas de mon épaule.

Je dois chercher ailleurs. D'accord ? Je vais penser à la douleur neurologique. C'est quoi une douleur neurologique ? Ça veut dire que c'est le nerf qui est touché et je vais avoir une douleur

qui éradique le long du métamer qui éradique par le nerf.

D'accord ? Alors la douleur, déjà, elle est décrite par le patient et j'ai mal ici et ça éradique. Elle peut descendre jusqu'à un doigt. D'accord ? Ce n'est pas une douleur localisée.

C'est une douleur qui prend un chemin de irradiation. D'accord ? Et normalement, selon le nerf ATA, elle va suivre avec le métamer irradié par le nerf. D'accord ? Comment il est décrit par le patient ? Est-ce que vous avez déjà entendu ça autour d'eux ? Oui ? Alors, par exemple, le décormiement Ça, c'est un mot un peu à l'examen.

Alors, qu'est-ce que le patient peut-il dire en l'air ? Vous comprenez ? Il peut ne pas sentir. Il ne sent plus par ses doigts, par exemple. D'accord ? Oui ? Lourde.

Plié. Alors là, vos mamans, vos grands-mères, elles me disent que une fois le matelas avec la couverture est tombé, elle a du mal, juste le matelas, elle a du mal à la faire, à se recouvrir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas cette lourdeur.

Quand vous avez ça, c'est que vous pensez aux nerfs, d'accord, qui viennent de l'architecture. C'est-à-dire que l'électricité, le courant d'électricité, les piqûres d'abeilles, etc. D'accord ? Quand vous entendez ça, réflexe, c'est attention, c'est le nerf qui attend.

D'accord ? Alors, bien sûr, on va faire un examen neurologique détaillé à la recherche d'hypoesthésie, d'anesthésie, d'une diminution de la force musculaire, du testis musculaire et là aussi, les articulations sont tout à fait libres. Maintenant, pourquoi douleur de l'école ? Ce n'est pas l'école qui est douloureuse, qui est la source de la douleur, ce n'est pas le nerf. Je dois penser à attention.

Chez un nerf, attention à la douleur de l'épaule gauche, ça peut venir du coeur. Attention, est-ce qu'il n'est pas en train de faire des petits signes de l'engorge ? D'accord ? Est-ce que ce n'est pas le courant ? Pour les gens fumeurs d'un certain âge, il y a les tumeurs de l'apex, qui peuvent, c'est-à-dire être ressentis uniquement au niveau de l'épaule. C'est ce qu'on appelle les douleurs projetées, au nom référé.

D'accord ? Les douleurs projetées, ça veut dire que je sens, c'est une douleur qui vient ailleurs, d'ailleurs, mais je la ressens au niveau de mon articulation. C'est bon ? Alors, quelques exemples. À tête de la hanche, c'est la hanche qui est la source de problème, mais je ressens la douleur au niveau de mon genou.

C'est pourquoi, un réflexe, devant toute douleur du genou, je dois, je vais examiner le genou, mais je ne dois jamais oublier d'examiner la hanche. Les lésions viscérales, le cœur, douleur de l'épaule gauche, la vésicule lumière au niveau de l'épaule droite, du cerveau vert, je peux ressentir la douleur, non pas ici au niveau de l'appendice viscérale, mais je vais la ressentir ici. D'accord ? Le rein, je irradie vers l'orachis lombaire.

D'accord ? Très bien. Si on peut, faire une petite synthèse jusqu'à maintenant. Combien de douleurs nous avons ? Peut-être d'origine osseuse.

Tout le monde sait comment douleur osseuse. Éveillez-vous ! Vous venez de commencer l'année scolaire. Très bien.

C'est à l'appui de l'os. Très bien. Alors l'os, ça peut partir de l'épiphyse, métaphyse, diaphyse.

C'est bon ? Le premier élément à égarder, c'est que la mobilisation très douce et progressive de mon articulation, je vais me rendre compte qu'elle est une partie libre. Très bien. Deuxièmement, douleur, c'est l'articulaire, c'est l'articulation.

L'articulation peut être remplie, comme ce que je vous ai montré. D'accord ? Vous pouvez avoir des signes à faire avoir, notamment la hauteur, la chaleur vocale, l'augmentation, l'arrêteur. Très très bien.

L'arrêteur, c'est quoi ? C'est la limitation de la mobilisation. Très très bien. J'ai mal, je ne peux plus faire l'abduction.

C'est bon ? Douleur ? Musculaire. Pareil. C'est simple, c'est aussi simple que si ça s'accompagne d'un necrophile où là on est en train de tuer ma passion.

Mais c'est loin de l'articulation. Ce n'est pas l'os. Je peux même faire une petite pression à l'axe du muscle et je vais me rendre compte que c'est le muscle qui est la source de la douleur.

Si maintenant tout est normal, il faut chercher, est-ce que, très bien, est-ce que mon articulation est sur le trajet d'un nerf ? Je dois voir. Et là, c'est très facile quand il y a des paresthésies. Les paresthésies peuvent être douloureuses comme elles peuvent être désagréables.

Il est gêné. Il agit. Le ventre, la lourdeur, etc.

Si maintenant tout est normal, c'est qu'il faut chercher. Il faut chercher autre chose. Deuxième objectif, c'est de savoir définir les caractéristiques sébiologiques de la douleur.

C'est un point qui est très intéressant. Est-ce que c'est une douleur mécanique ? Est-ce que c'est une douleur déclaratoire ? Est-ce que vous arrivez à faire la part entre les deux ? Donnez-moi un exemple. La tendinite, c'est un ? Un inflammatoire.

Pourquoi un inflammatoire ? Je parle suffisamment. Justement, très très bien, vous avez bien pensé, mais ce n'est pas ça. C'est pourquoi on retourne sur le mot tendinite, parce que finalement, ce n'est pas le caractère inflammatoire et on parle de tendinopathie.

D'accord ? Mais la tendinite, c'est une douleur la patiente, notre camarade qui a ressenti. C'était inflammatoire ou c'était crevé ? Ou c'était mécanique ? Tu ne sais pas. Très bien.

C'est quoi inflammatoire ? Inflammatoire, je vais vous donner un exemple. Quand vous avez une arthrite septique, vous savez c'est quoi une arthrite septique ? Non. inflammatoire signifie qu'il y a un problème sérieux au niveau de l'articulation.

Soit qu'il est inflammé, c'est une inflammation, il peut être causé par un agent infectieux. Et on parle d'une infection comme là, une arthrite septique, ça veut dire qu'il est causé par un germe septique. Vous imaginez, c'est une articulation qui est comment ? C'est une urgence parce que vous avez une bactérie, un virus à l'intérieur de l'articulation.

Là, la douleur, au cours d'un rhumatisme inflammatoire. La douleur est inflammatoire. La douleur inflammatoire, c'est une douleur qui est ressentie, qui est présente.

Le matin, au réveil, au cours de la journée, elle réveille le patient, c'est la douleur qui réveille le patient, la nuit surtout, le tiers, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit. C'est des termes que vous allez entendre au fur et à mesure. C'est une douleur qui n'a pas de rapport avec l'effort.

Ça veut dire j'ai tellement mal que ça ne suffit pas que je me repose, que je dors pour ne pas avoir mal. C'est une douleur. Il faut que, quel que soit, que je sois au repos, que je sois à l'hôpital, ça fait mal.

Deuxième critère, c'est que le patient vous dit je me réveille, je suis raide. Raide dans les dents, c'est-à-dire que moi j'ai envie que je sois à l'hôpital. Ça veut dire qu'il s'accorde le matin qu'il ait soixantaine de chiquets.

Une chiquette. Ça c'est le mot très bien. Une chiquette ou un chiquet.

Ça veut dire qu'il a du mal, s'il a mal au niveau des doigts, il ne peut pas mobiliser les doigts au matin. Il ne peut même pas faire la flexion. Et ça demande un peu de temps.

Le caractère inflammatoire est défini par quand le dérouillage dépasse 28 heures. Si vous avez un dérouillage de plus de 2 heures, vous êtes en inflammatoire. Ces douleurs s'accompagnent de réveils nocturnes.

Les réveils nocturnes, vous allez préciser est-ce que c'est juste au changement de position. Parce que je peux avoir mal au dos. Vous avez mal au rachis cervical.

Je me repose, ça va. Quand les examens se terminent, je me sens mieux. Ça c'est le caractère mécanique.

Ça fait la différence. Maintenant je dors, je suis bien, parce que je trouvais une position antalgique. Mais dès que je vais changer de position, je vais avoir mal.

Ça, ce n'est pas inflammatoire. Pourquoi ? Ce n'est pas la douleur qui se réveille de la petite position, c'est la douleur qui se réveille. Non, c'est le changement de position.

C'est bon ? Alors, douleur mécanique, c'est une douleur qui apparaît au cours ou après l'effort. Elle est maximale en fin de la journée. Elle est tenue par le repos.

Par exemple, elle est due à la préparation. Quand je termine les examens, j'ai un peu moins mal. Alors déjà, je n'ai plus mal.

Elle était due juste à l'effort de la préparation. Elle s'accompagne d'un déroulage matinal. Mais elle est très courte, inférieure à 30 minutes.

Et pas de réveil nocturne lié à la douleur. On a dit qu'elle est liée surtout au changement de position. C'est bon ? Vous avez un peu compris ? C'est très important cette notion parce que vous allez l'approuver chaque fois et en chaque spécialité.

D'accord ? Mécanique, pourquoi c'est mécanique ? C'est lié au mouvement. D'accord ? On ne parle pas de l'intensité. Quand vous avez très mal, c'est normal que chaque petit mouvement va aggraver la douleur.

Mais on parle de compilé lié à l'effort ou à la mobilisation. Quand j'arrête l'effort, je vais me sentir mieux. D'accord ? C'est le caractère mécanique.

Le caractère inflammatoire, il n'a pas de problème avec l'effort. Par exemple, j'ai mal au repos. Vous imaginez si je fais un effort, je vais encore aggraver ma douleur. C'est normal, mais ça n'a pas de problème.

Je ne me connais pas en rapport avec le mouvement. Non. Mais quand je vous dis une douleur inflammatoire peut s'aggraver avec l'effort, oui.

Pourquoi vous dites oui ? Vous devez faire attention à la terminologie. C'est une douleur liée en rapport avec l'effort inflammatoire. Elle peut être aggravée par l'effort.

C'est différent. Vous avez mal au repos quand vous faites un effort. Ça va ? C'est pourquoi je vous demande votre attention.

N'ayez pas peur. Je suis là pour vous aider. J'ai 6 QCM.

J'aimerais bien que vous l'étayez. Très bien. Une douleur aiguë.

Une douleur aiguë c'est quand vous avez une douleur inférieure qui dure moins de 3 mois. D'accord ? Quand c'est plus de 3 mois, on est dans la chronicité. C'est une douleur chronique.

Une douleur récente aiguë ayant débuté il y a 2 ou 3 jours n'a pas la même signification qu'une douleur très ancienne. D'accord ? Le patient qui vient vous voir qui a un gros genou avec une douleur très importante apparue il y a 3 jours, ce n'est pas comme un patient qui traîne des douleurs depuis 10 ans. Alors, la douleur, il y a des moments d'acalémie, ce n'est pas le même.

Alors, douleur à fleur à bois, douleur mécanique, aiguë, chronique. D'accord ? C'est bon ? Pour la douleur, est-ce que vous connaissez des patients qui sont trop plaintifs ? Vous en avez certainement autour de vous. Les gens ne sont pas aigus face à la douleur.

Oui, vous avez déjà remarqué ça. Il y a la maman, vous savez qu'elle a mal, vous êtes sûr qu'elle a mal, mais elle vous dit non, non, non, j'ai une douleur, j'ai une douleur. C'est quelqu'un qui souffre, mais parce qu'il a d'autres priorités, parce qu'elle va vous faire à manger, elle doit vous faire de la dalle, elle va, hop, elle ne dit pas qu'elle a de la douleur.

Elle n'a plus c'est que son mari n'a pas les moyens par quoi il va aller tâcher sa douleur. Et il y a de notre côté des gens qui, pour rien, mais pour rien, ils vont partir jusqu'à l'IRM. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend quoi ? Que la douleur elle est comment ? Elle est très subjective, elle est très subjective, du coup je ne peux pas comparer ta douleur de l'autre douleur, je ne peux pas dire ah, il souffre plus que celle-là.

Non, d'accord ? Mais pourquoi ? Pour ce qu'on appelle l'intensité, pour savoir l'intensité d'un patient, est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il ne dit pas vrai ? Finalement, on ne juge pas le patient. Alors je suis volé, la tête suit, là où est-ce que j'étais ? Je suis là pour le soulager. Pourquoi il fait ça ? Et c'est pourquoi on a pensé, et cela, c'est génial au Maroc, de façon universelle, à avoir des petits outils, des petits outils qui nous permettent de voir l'intensité de la douleur.

Mais l'intensité, j'insiste, il ne sert pas à comparer x à y, il va être utile pour la dose de médicaments et les yeux. Tu t'approches. C'est à comparer le patient lui-même dans le temps.

D'accord ? Parce que là, Julio m'a dit 8 sur 10. Après, je vais lui donner un traitement, 48 heures la semaine, je vais demander. Vous m'avez dit la dernière fois que vous êtes 8. Est-ce qu'il y a un petit soulagement pour vous sécuriser d'autres douleurs ? Après, ça sert, c'est cette échelle, à comparer le patient lui-même par rapport à lui-même, et ça va me servir moi.

Est-ce que je dois garder le même traitement ? Est-ce que le clinique, on n'aime pas la consultation, parce que on va lui donner toute la pharmacie, il va avoir toujours mal. D'accord ? Très bien. Chose qui est, alors on va voir l'intensité, et le retentissement.

Il y a des gens analphabètes, les femmes qui n'ont jamais, qui ne sont jamais allées à l'école, c'est très difficile. Je vais lui dire, s'il vous plaît, situez-moi votre douleur de 0 à 5. 5, c'est le maximum des douleurs que vous pouvez. S'il a déjà des enfants, je vais comparer 7, 7 à 10 à l'accouchement.

L'accouchement, on a une fracture très intense, et 0 quand vous n'en avez pas. Dès qu'il entend des chiffres, il se bloque. Je ne sais pas.

D'accord ? Je peux déduire la douleur comment ? C'est en cherchant le retentissement. D'accord ? Par exemple, une douleur qui peut retentir sur la vie d'un patient. Donnez-moi un exemple.

Très bien. Alors, ça peut aller de petits gestes quotidiens. C'est une patiente, par exemple, d'un certain âge, qui a une bonne arthrose, une douleur qui dure dans le temps, qui a la chambre à coucher au troisième, au deuxième étage, et il vous dit « ça fait trois ans que je n'ai pas vu ma chambre ». Est-ce que vous imaginez ? C'est très handicapant.

Elle ne peut plus monter les escaliers. C'est très gênant. Vous imaginez un sportif, maladonné, il s'est cassé le ligament, le baptême.

C'est toute une carrière. C'est toute une carrière qui peut chambouler. Le retentissement est très important.

Et chacun, selon sa vie, ça peut aller des milliards, ça peut causer la perte de milliards, comme ça peut causer la petite. C'est la femme qui ne peut plus monter à sa chambre. D'accord ? C'est le monsieur qui trouvait du plaisir à faire les rondonnées.

Il ne peut plus. Alors là, le retentissement est très important. Troisième chose qu'il faut chercher, c'est les signes accompagnateurs.

Par exemple, les signes accompagnateurs. C'est le caractère mécanique. Oui, les signes accompagnateurs.

Qu'est-ce qu'il vous dit ? Des mots de paix ? Non. Les signes inflammatoires, c'est à l'examen, mais on met toujours à l'interrogatoire. Oui.

Avec l'examen. D'accord ? Là, c'est la fièvre. Il faut chercher la fièvre.

Signes accompagnateurs. Le patient vous dit j'ai mal au genou. Mon genou a gonflé.

Ce qu'on avait dit, je vais chercher est-ce que c'est inflammatoire ? Est-ce que c'est mécanique ? Est-ce que ça évolue depuis 10 ans ? Ça n'est pas comme si ça évolue depuis 3 jours. Le gonflement. Est-ce que c'est un germe ? Est-ce que c'est une bactérie ? Est-ce que c'est une arthrose ? Comment faire la barre ? C'est la fièvre.

Est-ce que quand vous avez mal, quand ça a gonflé, est-ce que vous avez eu de la fièvre ? Est-ce que vous avez eu des sueurs ? D'accord ? Ce sont les signes accompagnateurs. Maintenant, un sujet âgé qui vous dit j'ai maigri. Vous avez remarqué qu'il n'a plus faim.

C'était un bon vivant, un grand mangeur. Et d'un coup, il a tout le temps il n'a plus il n'a plus il se sent toujours il n'a plus rien de manger. C'est une perte totale de l'appétit.

Ce sont des signes attentions, alarmants. C'est ce qu'on appelle altération de l'état général. Altération de l'état général associe 3 A. Anorexie.

Anorexie, c'est la perte totale du plaisir de manger. Il n'a plus le temps. Il ne veut plus manger.

Asthénie. Asthénie, c'est la fatigue. C'est la grande fatigabilité.

Le matin, le soir, qu'il fasse un effort comme il est au repos, il est toujours asthénique. Et, bien sûr qu'il ne mange rien, il va mépris. C'est un amigrisme.

Si vous avez ces signes, attention, il faut penser à un premier signe, notamment néoplasie. C'est un cancer. On n'aime pas prononcer le cancer parce qu'on vous prépare par la terminologie.

Si vous faites la visite au lit du malade, dès qu'il entend qu'il soit à l'infra-tête, qu'il soit à la dent, dès qu'il entend cancer, il voit le cancer. En parlant du néoplasie, je suspecte une néoplasie des métastases, des choses que vous voyez et ne comprenez pas. C'est bon ? La densité de la douleur.

En premier petit échelle, on a ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique. C'est par cette réglette. Une petite réglette.

Vous voyez, il y a une chaise. Venez-vous. Cette réglette, il a deux facettes.

Je vais montrer au patient cette facette où il n'y a pas de graduation, il n'y a pas de chiffre. Rappelez-vous, l'infra-tête, dès qu'il entend des chiffres, il est bloqué. Je vais lui dire, vous voyez qu'il y a un curseur que je peux mobiliser.

Je vais lui expliquer. Je vais prendre mon temps à m'y expliquer. Là, c'est quand vous n'avez pas de douleur.

Quand vous êtes bien. Et l'autre, il y a le maximum de douleur. Si ça est une femme, vous vous rappelez le jour où vous avez accouché, ça c'est l'extrême de la douleur.

Ou un patient qui s'est fracturé, c'est une douleur extrême qui n'a jamais eu aboulement. Et je vais lui demander de me chiffrer entre pas de douleur et le maximum de douleur. Et de me suivre.

De mon côté, supposons qu'il a placé son curseur ici. De mon côté, le dossier du médecin, ça correspond à un chiffre. Je vais le noter dans le dossier de la manette.

C'est bon ? Je répète. C'est un échec qui permet juste de suivre le patient lui-même dans le temps. Pour juger ma thérapeutique.

C'est clair ? Ça ne peut en aucun cas permettre de comparer un patient à un autre. Bien. Il y a ce qu'on appelle des chaînes numériques.

Là, c'est 5. 0. Pas de douleur. Faible. Modérée.

Intense. Extrêmement douloureux. Je vais expliquer ça au patient.

D'accord ? Je vais dire 0 pour la médecin là-bas. Et il va me donner un chiffre. Ah oui, là, il y a des chaînes verbales.

Simple. Je vais lui dire entre 0 et 10. Voilà.

Tous vos 10 correspondent à 3. 0 à 3. Et il donne un chiffre. Le retentissement. Parfois, je ne peux pas.

Alors, je vais lui dire ça fait un bout de temps que vous avez mal. Quand vous avez mal, est-ce que vous prenez un médicament et diminuez ma douleur ? Dès que je prends un comprimé de Doliprane, je vais bien. Qu'est-ce que vous avez compris ? C'est une douleur qui est de la faible à modérée parce qu'un serpent primé d'un montage du Doliprane a suffi.

Un autre va vous dire Doliprane à partir de 1, je n'ai plus. Il n'y a plus d'efficacité sur Doliprane. Je prends l'anti-inflammatoire.

Il y a d'autres qui ne prennent que Doliprane. D'accord ? De là, on peut déduire l'intensité de la douleur. D'accord ? Le retentissement fonctionnel.

C'est la résultante de la douleur. De la raideur. Il faut apprécier les conséquences sur les activités de la vie quotidienne.

La marche, monter des escaliers, l'habillage. Il y a des gens qui nous disent ça fait un bon temps que je ne peux même pas faire mes lacets. Est-ce que vous imaginez un homme ou une femme qui peut faire ses lacets et donner un à son fils ou à sa femme ? C'est une vraie gêne.

D'accord ? Donc, pour le patient, peut-être vous vous la banalisez, mais pour un patient qui était actif, qui était jusqu'à hier actif et il faisait tout, il se trouve dans l'incapacité. D'accord ? Les conséquences socio-professionnelles, le sport. Si maintenant le patient a mal au dos et il travaille dans une usine à port de charge, il vient me voir, je vais lui écrire un rapport d'aménagement de poste.

L'usine n'a pas de poste lui correspondant parce que l'usine est ouverte de temps. Ils vont le licencier. Même s'il passe au tribunal, il ne va rien gagner.

Vous imaginez tout. Le retentissement peut être parfois très important. Mais s'il accompagne à deux ou trois moments tardé la fièvre, l'essuieur, l'altération de l'état général, l'amélioration de l'anorexie, l'asthémie, est-ce qu'il y a des lésions cutanées ? Est-ce qu'il y a des brûlures fonctionnelles ? Est-ce qu'il y avait ça ? C'est d'essuieur accompagnateur, surtout si je m'oriente vers une arthrité.

Un gros genou, un inflammatoire, un boudoir inflammatoire, qui évolue depuis trois jours. Attention, c'est un microbe. C'est une arthrité causée par un germe.

Il faut que je trouve le germe, la porte d'entrée de ce germe. Alors là, est-ce qu'en jouant le foot, il ne s'est pas blessé ? Est-ce qu'il y a une plaie cutanée qu'il a négligée ? Il pourrait être source d'infection. Est-ce qu'il a eu des brûlures fonctionnelles, des diarrhées, etc.

D'accord ? Est-ce que c'est OK ? Vous me suivez tous ? Très important. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est tout compris ? Vous ne dormez pas, c'est sûr, n'est-ce pas ? Bien.

Alors, maintenant, arthralgie, arthropathie, arthrite, moulot, oligo. Arthralgie, algie, c'est une douleur. Très bien.

Arthragie, c'est une douleur articulaire. Arthropathie, pathologie, maladie, maladie de la pathologie. J'allais dire une pathologie articulaire.

Thondinopathie, c'est une pathologie du tendon. D'accord ? Arthrite, suffixe "-ite", veut dire inflammation. Au niveau d'une articulation, qu'est-ce qui peut être inflammé ? C'est la membrane synoviale.

C'est pour cela si je vous dis arthrite, c'est synonyme à une synovite. D'accord ? Très bien. Maintenant, j'ai eu arthrite, le patient a eu arthrite, je dois lui demander combien d'arthrite il a. S'il a une seule, on parle de ? Monoarthrite.

Faites cela. Répétez avec moi. C'est comme ça que vous allez apprendre.

Allez-y. Deux. Trois articulations.

Polypoarthrite. C'est comme ça que vous allez vous réveiller. Polyarthrite, c'est comment vous avez plus que votre articulation.

C'est bon ? On répète. Arthralgie. Articulaire.

Et bien, arthropathie. Orthologie articulaire. Arthrite.

Monoarthrite. Deux, un, trois articulations. Polypoarthrite.

Et bien, plus de quatre articulations. Polyarthrite. Vous avez 10.

Alors maintenant, maintenant, vous avez, je sais que c'est nouveau, tout est nouveau, supportez-moi. Alors maintenant, on a terminé notre anamnèse. Ça veut dire, à la fin de mon interrogatoire, je dois avoir une petite synthèse.

Je dis, je vais dire, mon patient a, par exemple, une polyarthrite. Le caractère inflammatoire, il est aigu. J'ai cherché, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des signes accompagnateurs ? Il n'y a pas de fièvre.

Il n'y a pas, il n'y a pas. Ça veut dire qu'à la fin, je dois avoir une petite synthèse. Pourquoi cette synthèse ? Parce que c'est par cette synthèse que je dois avoir une orientation dans ma tête.

Je passe à l'examen pour examiner l'articulation. Le médecin est un bon conservateur. Rappelez-vous toujours la patiente de l'intime.

L'intime, vous allez la toucher ici. C'est pourquoi il faut l'observer. Je vais lui demander de monter sur la chaise.

Je vais voir qu'elle monte sans problème. Alors dès que je vais toucher, ça, c'est juste un inspection. Je vais me rencontrer elle-même.

Il y a une grande part de subjectivité. D'accord ? Vous devez être un bon conservateur. L'examen se fait sur un malade député en short.

D'accord ? Vous ne devez rien laisser. Vous devez le voir. Est-ce qu'il y a des syncutènes ? Est-ce qu'il y a une asymétrie ? Est-ce qu'il y a une déviation des courbures du rachis ? D'accord ? Je ne peux pas voir ça si mon patient est abîmé.

Mais si il a mal en une seule épaule, je dois examiner l'autre épaule toujours de façon comparative. On doit aussi toujours examiner, comme m'a dit tout à l'heure notre camarade, n'oubliez jamais que si j'ai mal au genou, je ne dois jamais oublier d'examiner les articulations suces et souges ensemble. L'inspection.

Qu'est-ce que je peux voir à l'inspection ? Une durée d'action. C'est l'augmentation du volume. Un myotrophie.

Un myotrophie, c'est la diminution de la masse musculaire. Je peux voir la courbe au rachis d'intégrément. Ça veut dire que c'est rouge, c'est lumineux.

Il y a des couleurs. Est-ce qu'il y a une plaie ? Est-ce qu'il y a des varices ? Je peux tout voir à l'inspection. Un épanchement articulaire.

C'est une articulation. Il y a un problème ? Il y a un problème ? Ça me dérange vraiment. Vous n'êtes pas intéressé, vous sortez.

Vous n'avez pas de problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? J'attends. J'attends votre décision.

Ça commence bien à aller. Bon. Une articulation qui est augmentée de taille.

C'est ce qu'on appelle un épanchement. Une subluxation. Un patient qui a le signe de l'épaulette.

Une subluxation de l'épaule. Vous allez avoir votre acromion qui est comme si le patient avait une épaulette. D'un côté.

Déformation. Attitude vicieuse. Voici quelques exemples.

Regardez ces mains. Ce que vous voyez, ce sont des mains qui sont déformées. Ce sont des déformations qui sont fixes.

Regardez les déformations. C'est ce qu'on voit dans la boule de l'arthrithromatomie. Le crèveur.

Regardez. Cette tubule est inflammée. Vous voyez les signes de l'inflammation.

Les signes de l'inflammation sont en nombre de 3. Il y a la tubéfaction. C'est l'augmentation du volume de l'articulation. C'est la rougeur.

Et le troisième, c'est la chaleur. Je porte la palpation. Je porte la palpation.

Les signes inflammatoires, c'est les 3 signes. Tubéfaction, chaleur, augmentation de la chaleur, et la rougeur. Et vous voyez que tout le pied est démassé.

C'est une tubéfaction, c'est une monoharthrite de la cheville avec EDM du pied. Juste à l'inspection. Vous voyez ce genou par rapport à l'autre.

Il est gonflé. Mais, est-ce qu'il y a des signes inflammatoires ? Non, il n'y a pas de signes inflammatoires. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un épongement.

Quand vous avez une augmentation du liquide qui est augmenté de taille, on parle d'épongement. D'accord ? Mais quand vous avez des signes évidents d'inflammation, là, c'est une inflammation jusqu'à la rote du pancréas. Est-ce que c'est infectieux ? Est-ce que c'est traumatismatique ? C'est ce que je vais chercher par l'équivalent.

Vous voyez, vous voyez la différence ? Alors là, regardez le signe de l'épaule. Le patient, il s'est luxé. La tête, elle est soit en arrière, soit en bas, et ce n'est que l'acromiant.

Avec, bien sûr, la myotrophie qu'il a. C'est bon ? Oui ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on peut laisser ? On les entend ? Bien sûr, non ? Mais ici, infirmièrement, c'est l'inflammation. Maintenant, autre question. La palpation.

Qu'est-ce qu'on cherche à la palpation ? Essentiellement, les points d'œuvre. Très important. Parce que si maintenant j'ai un point d'œuvre, vous l'aurez localisé.

Je dois m'orienter vers une atteinte, soit ligamentaire, soit tendineuse, soit célatérite, d'accord ? Ce n'est pas comme une douleur qui est diffusante. Et bien sûr, cela n'est possible que par la connaissance de l'anatomie. Je dois savoir ce point correspond à quelle insertion musculaire l'avons dit.

Recherchez une augmentation de la chaleur locale et bien sûr, l'épanchement. On va voir ça au niveau du genou. C'est bon ? Jusqu'à maintenant ? Vous pouvez avancer.

Maintenant, on a examiné, on a observé, on a palpé, d'accord ? On va passer à la mobilisation. On a parlé tout à l'heure de la mobilisation. Il y a la mobilisation active et passive.

Active, c'est ? L'effet. L'effet du mouvement. J'ai mal au niveau de mes poignets.

Je lui ai demandé de faire l'antépistole. Je vais voir, est-ce qu'elle peut faire comme... Je lui ai demandé de faire la rotation extérieure, etc. D'accord ? Maintenant, passive.

Là aussi, c'est pour juger. Et finalement, comment je peux savoir, là aussi, que le passant est réel, qu'il y a une limitation ? Je dois connaître les amplitudes normales. D'accord ? Ça veut dire que je dois connaître l'épaule qui est sans le mouvement et jusqu'à où je peux aller.

La rotation extérieure est à la fois. La rotation intérieure est à la fois. Tout repose sur l'amplitude.

Les amplitudes articulaires diffèrent d'une amplitude d'une articulation à une autre. Et on a ce qu'on appelle le goniomètre. Le goniomètre, c'est pour mesurer les angles exprimés en degrés.

Et bien sûr, là aussi, on va suivre le passant dans le temps. D'accord ? Voilà. Par un exemple, le genou, l'extension, vous devez avoir le membre qui est bien étendu.

Rappelez-vous l'autre genou qui avait là, on avait un grand plaissage. Ça veut dire un grand espace entre le genou et le plan du lit. D'accord ? La mobilisation passive, c'est les animateurs qui mobilisent, et active, c'est le médecin qui fait la mobilisation.

Pourquoi active et passive depuis tout à l'heure ? Parce que, si vous avez remarqué, on n'a pas bien, jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de tendinopathie. Quand est-ce que je peux parler de tendinopathie ? Pardon ? Très, très bien. Ça veut dire que le patient, il y a une patiente qui vient me voir comme ça.

D'accord ? Je vais lui dire de mobiliser le... Elle me dit, est-ce que je fais la mobilisation par l'autre ? Elle fait la mobilisation de ce membre par l'autre main. Sinon, elle ne peut pas. D'accord ? Elle est la mobilisation active, parce qu'il est impossible à normal.

D'accord ? Mais, puisque elle arrive à faire de l'autre côté, c'est comme si moi aussi, je le fais. D'accord ? Si vous avez une patiente comme ça, qu'est-ce que vous allez dire ? Est-ce que c'est une luxation ? Est-ce que c'est une fracture ? Est-ce que l'articulation est raide ? Mais, de l'autre main, elle arrive à faire. C'est juste la mobilité active qui est impossible.

Et, quand je vais examiner, je vais trouver que l'articulation est libre. C'est dans ce cas que je vais m'orienter vers une atteinte du tendon. D'accord ? On va voir ça dans l'examen de l'école où elle fait.

Là, je vous demande de retenir ça. On pense à une atteinte du tendon quand vous avez la mobilisation active anormale. On va dire anormale.

Est-ce qu'il est possible ? Est-ce qu'il est impossible ? Mais, elle est anormale. Alors que la mobilisation passive est tout à fait normale. Non.

C'est quoi la différence ? La neurologique de la chimie. Je ne connais pas le nombre qui est tendant. Elle ne peut pas mobiliser.

Elle ne peut pas. Ce n'est pas la lourdeur. C'est l'articulation qui ne peut pas mobiliser.

Alors, oui. Si on s'en est ralenti parce qu'on a pris beaucoup de temps, un truc soit fait. D'accord ? C'est là qu'on va voir la mobilisation en train.

C'est bon ? Un épanchement articulaire. Je suis après que Diaco. Épanchement articulaire, c'est quand on a une augmentation de la sécrétion du liquide.

C'est-à-dire que c'est le liquide en grande abondance, en grande quantité. D'accord ? Il peut être d'origine inflammatoire, comme il peut être d'origine mécanique. D'accord ? L'épanchement est difficile à mettre en évidence sur une articulation profonde.

C'est tout facile de faire, c'est-à-dire à le mieux, de voir que l'augmentation est superficielle, une articulation augmentée de taille. Mais pour la hanche, c'est difficile. C'est pourquoi on demande la démographie pour voir s'il y a un épanchement.

On peut avoir une bursite, c'est quand vous avez l'épanchement dans la bourse. Voici quelques exemples. Regardez ce coude où il y a une augmentation du volume de toute l'articulation.

Regardez la différence quand vous avez une bursite. C'est ce qu'on appelle un nigroma. La bursite rétrouve au nez crâne.

D'accord ? Vous appuyez à force la différence. Quand il y a un épanchement, que ce soit mécanique ou inflammatoire, au niveau de l'articulation, c'est toute l'articulation qui est gonflée alors que la bursite est localisée. Dernière diapo, c'est juste un prédit.

Vous avez la plus grande pathologie mécanique étant l'arthrose et vous avez de l'autre la polyarthrite ou maturida. L'arthrose, c'est quoi le problème ? C'est une plus dure du cartilage. La polyarthrite, c'est la lésion élémentaire liée à la débutante.

Elle est causée par quoi ? Par l'effort, le vieillissement et le bois. Ça veut dire que c'est la charge. C'est la charge.

D'accord ? Alors, près de la charge, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir un pincement du bois localisé. C'est-à-dire que soit c'est sur le plan interne où il va y avoir le pincement. Ce n'est pas un pincement qui est global.

C'est un pincement qui est localisé. Et par la charge, il va y avoir un dessin en bas qu'on va voir.

Alors, l'ostérose, c'est une maladie dégénérative.

D'accord ? La lésion intéresse au premier le cartilage. C'est une pathologie dégénérative. C'est normal.

La douleur, elle est comment ? Elle est mécanique. Elle est liée à l'effort. Vos grands-mères, quand ils sont au lit, quand ils ne font pas d'effort, ils sont bien.

On dirait qu'ils n'ont rien. Dès qu'ils commencent à marcher, ils vont avoir mal. Quand on fait un bilan, le bilan inflammatoire est tout à fait normal.

D'accord ? A l'opposé, l'arthrite. L'arthrite, c'est une maladie inflammatoire. Alors, l'arthrite, dès qu'on a des signes inflammatoires, il faut chercher qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui a causé cette inflammation ? Il peut s'agir d'un germe, d'une bactérie, d'un virus, d'un champignon.

Il peut s'agir d'un problème auto-humain, notamment le rhumatisme. D'accord ? La lésion intéresse la synovite. C'est une réaction de la membrane synoviale.

La douleur est inflammatoire. Le liquide articulaire, parce que quand on a un épanchement, il faut considérer tout épanchement comme pathologique. Il faut aller faire une piqûre, d'accord ? Une injection par la déclasserolale et on fait retirer du liquide pour l'acheminer au laboratoire.

Tout épanchement doit être fonctionnel. Et comme ça, on peut avoir l'affaire du germe. Quand on fait le bilan inflammatoire, la vitesse de sédimentation est accélérée.

Ça veut dire que il y a de l'inflammation au niveau de l'organisme. D'accord ? Sur le plan radiologique, regardez, ici c'est l'arthrose. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors le placement, il est localisé.

De l'un côté, ils vont se joindre. De l'autre, ils vont s'ouvrir. C'est pourquoi que les femmes d'un certain âge, ou là les hommes, vont avoir un génie varone.

Ça veut dire que je n'avais pas le génie varone, je commence à avoir les membres inférieurs en parenthèse. Pourquoi pas ? C'est ce placement d'un côté et l'autre qui s'ouvre. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici ? Le placement qui est localisé, il y a ce qu'on appelle des osmophytes.

Ce sont des excroissances, parce que du fait des charges, l'osmocondrile, il tente, dans une tentative de réparation, il va lutter. Il va lutter et on va se trouver devant des surfaces qui s'élargissent. Le genou qui devient grand.

Mes chiffres là, comment on appelle ça ? Ce sont des surfaces qui vont être élargissées par cette tentative de réparation. on va voir qu'il y a dans la radio, si vous voulez dire les blancs, là où il y a le placement, il va y avoir une ostéocondensation avec les osmophytes. Allons poser une arthrite.

L'arthrite, c'est quoi ? C'est une inflammation chronique dans l'articulation. Cette inflammation,

qu'est-ce qu'elle va causer ? Elle va faire au contraire. On ne va pas trouver une condensation, on va trouver une déminéralisation par l'inflammation via chronique.

Je ne vous demande pas de retenir ça, juste à titre indicatif. Très bien. On va passer aux vidéos.